

Laringitis

Bibliográfica Hospital Perrupato – Dr. Navarro David – 2019

Guías Hospital Garrahan

ECRI 2012

1- Subglótica (Crup viral)

“inflamación de las cuerdas vocales, puede asociarse a inflamación bronquial (laringotraqueobronquitis)”

ETIOLOGÍA:

- Infecciones virales: mayor frecuencia.
 - Parainfluenza 1-3: + Fr (otoño, primavera)
 - Influenza A y B (Invierno)
 - Adenovirus
 - VSR
- Infecciones bacterianas:
 - Chlamydia pneumoniae y Micoplasmapneumoniae
- Se lo puede observar como consecuencia de otras afecciones:
 - Reflujo gastroesofágico
 - Atopía

EPIDEMIOLOGIA: +fr de 6m a 2a

CLÍNICA:

- Afonía o disfonía
- Tos seca o perruna
- Estridor inspiratorio
- Febrícula
- CVAS 1-3 días previos
- Empeora frecuentemente durante la noche (4 AM)
- Duración de 2-7 días.

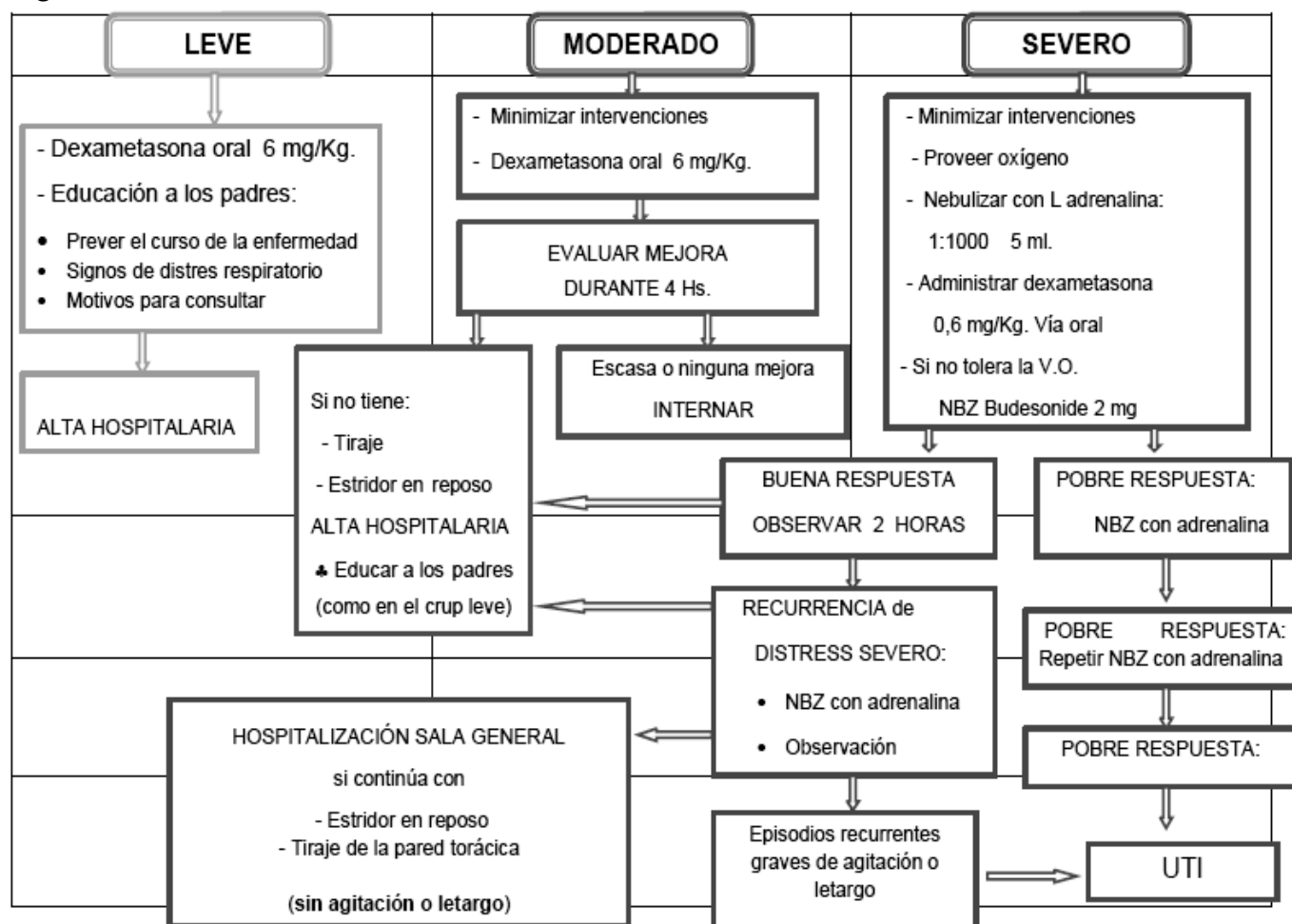
SCORE

SÍNTOMA	0	1	2	3
ESTRIDOR RETRACCIÓN	Ausente	Leve	Moderado en reposo	Grave (en inspiración y expiración) o ausente (con disminución considerable de la entrada de aire)
RETRACCIÓN	Normal	Leve	Moderada	Grave (empleo considerable de los músculos accesorios)
ENTRADA DE AIRE	Normal	Disminución leve	Disminución moderada	Disminución considerable
NIVEL DE CONCIENCIA	Normal	Intranquilo	Ansioso agitado	Letárgico o deprimido
COLOR	Normal			Pálido a cianótico

TRATAMIENTO:

Leve (<5 p)	• Estridor • Taquipnea • Ronquido	Ambulatorio: Humidificación con medio frío (nebulizaciones con 5ml de solución fisiológica) + Corticoides orales x 5días: • B-metasona o Meprednisona 1mg/Kg/día c/8hs
Moderado (5-8 p)	• + Tiraje	Ambulatorio/Internación: NBZ Budesonide 30 gt(1500µg) + 3,5 ml SF c/8-12hs + Rescate con corticoide: Meprednisona 1mg/kg/dosis. Mala tolerancia oral: dexametasona a 0.6mg/Kg/dosis + reglado
Grave (>8p)	• + Cianosis	Internación: Adrenalina NBZ + NBZ de Budesonide + Dexametasona EV Oxigenoterapia , valorar intubación

Algoritmo ECCRI



2- Supraglótica (Epiglottitis)

“Inflamación de la epiglottis que alcanza tejido adyacente”

Etiología:

- H. Influenzae + fr (no B luego de la vacunación)
- Otros:
 - Neumococo
 - Estafilococos
 - Estreptococos B-hemolítico

Epidemiología:

- +fr de 2-8 años
- +fr en invierno y primavera

Clínica:

- Inicio repentino (evolución fulminante en 4-6 hs)
- Fiebre alta
- Odinofagia, babeo
- Posición preferencial (sentado con la cabeza hacia delante, cuello alargado y boca abierta)
- Voz apagada
- Estridor (más suave que el Crup)
- Dificultad respiratoria con rápido empeoramiento

Tratamiento:

- De emergencia
- Internación en UTI
- Adecuada hidratación
- Corticoides EV
- ATB (luego de hemocultivos x2)
 - Ceftriaxona – Cefuroxima
 - Profilaxis de contactos < de 4 años

Rx de cavum: edema de zona (signo del “pulgar”)

Diferencial: Absceso, ingestión de causticos

